

INTEGRATED ECOSYSTEM STRATEGY

KIDUKI・睡眠クリニック・WorkTreat・CASETRA

統合戦略書 v2.0

休職・復職を入口に、産業保健の実行基盤を取る

戦略判断用

2026年8月5日

KIDUKI産業医事務所 × スリープリカバリークリニック番町 × WorkTreat × CASETRA

本書の構成

1. 戦略の一本化

購買起点、臨床レイヤー、Casetra、役割分離、標準Caseの完了定義

2. 競合と参入障壁

既存の産業医事務所・健康管理SaaS・復職支援・健診機関との違い

3. 商品・収益・流通の設計

Pack、医療連携、健診機関、情報ガバナンス、Web、GTM、90日計画、KPI

4. 根拠・確認範囲・前提

制度、公的ガイド、競合、自社公開サイト、ローカル実装、未確認事項

最重要の読み方：睡眠は入口の差別化レイヤー、休職・復職は購買起点、Casetraはスケールと参入障壁の中心です。

Executive Summary

睡眠クリニック、KIDUKI産業医事務所、WorkTreat、CASETRA、健診機関・連携医療機関を、役割分離と相互送客で束ねる統合戦略書。狭い課題で選ばれ、実運用で証拠を作り、CASETRAの全Case利用へ拡張する。

戦略結論「睡眠 × 休職・復職」だけではない。正しくは、就業判断の空白を完了させる事業である。休職・復職・就業継続が購買起点。睡眠は医学的に重要な差別化レイヤー。クリニック / WorkTreatは主治医側、KIDUKIは産業医側、CASETRAは会社側の実行管理を担い、CareLinkが公開済み最小情報だけを接続する。

最終目的

CASETRAをスケールさせる

KIDUKIとクリニックは強力だが、人依存の売上だけを増やすと上限が来ます。両者を有料の実証装置・初期流通網として使い、標準化したPackをSaaS / Partner / OEMで広げます。

診療とManaged支援は捨てない。ただし最終形の主役はソフトウェアと運用標準です。

1. 戦略の一本化

三事業を別々に売るのではなく、一つの未解決課題に対して役割の異なる三層を提供します。企業が買うのは「睡眠」でも「面談」でも「記録ツール」でもなく、案件が止まらず、適切な人が判断し、実行と再評価まで確認できる状態です。

Buying trigger

休職・復職・就業継続

頻度があり、放置コストが高く、人事が今すぐ説明責任を負う案件。

Clinical wedge

睡眠を含む医学的根拠

睡眠覚醒リズム、日中機能、治療状況、心身状態を、必要な範囲で構造化。

Operational moat

CASETRAで完了管理

同意、文書、面談、会社決定、措置実施、再評価、解除まで一つのCase。

Trust moat

役割分離と情報境界

主治医・産業医・事業者を混同せず、生データを会社へ流さない。

一文で言うと：「休職・復職・就業継続で、主治医・産業医・会社の間には落ちる判断・事務・再評価を、睡眠を含む医学的根拠とCASETRAの証跡で完了させる。」

エコシステムの役割

Clinical

睡眠クリニック

診断・治療、睡眠と就労機能の評価、本人同意に基づく医学的情報提供。就業可否の最終判断はしない。

- ・ 一般睡眠外来は独立運営
- ・ 両立支援外来は専用導線
- ・ 一般疾患は連携医へ紹介

Platform

CASETRA

全参加者を一つのカルテで混ぜるのではなく、権限を分けた一つのCaseで、必要な依頼・期限・成果物・決定・実行を結ぶ。

- ・ 復職標準 / 拡張Case
- ・ DecisionPack
- ・ M3・M6再評価
- ・ 他Caseへの追加展開

Occupational

KIDUKI産業医事務所

企業側の就業判断支援、就業措置案、復職後フォロー。既存産業医を置き換えるだけでなく、難しいCaseの補完役にもなる。

- ・ 産業医意見
- ・ 会社意思決定支援
- ・ 措置・再評価設計

Channel

健診機関

一般産業保健を奪わず、手間のかかる休復職・就業継続Caseの出口として紹介を受ける。逆に健診需要は連携先へ戻す。

Network

紹介医療機関

採血、生活習慣病、精神科・専門科などを担う。既存主治医を尊重し、競合ではなく患者供給源になる。

CareLinkとは何か——商品ではなく、境界を守る内部連携規約

定義：CareLinkは、WorkTreatとCASETRAの間で、本人が公開に同意した必要最小限の就業配慮情報と、その文書版・同意版・送付・受領の証跡だけを受け渡す内部API / イベント規約です。患者・企業に単独販売する第四の商品ではありません。

名称	座る側	保持するもの	保持・共有しないもの
WorkTreat	患者・主治医・医療機関側	勤務情報、会社確認、診療上の判断、官製様式又は準拠様式、診療録への格納、算定ゲート	会社の最終決定を代行しない

名称	座る側	保持するもの	保持・共有しないもの
CareLink	システム間の境界	published_scope、同意版、文書メタデータ、就業配慮要約、共有・受領時刻	下書き、同意前データ、診療録全文、検査生データ、不要な病名・請求情報
CASETRA	企業・産業保健側	依頼、期限、産業医意見、会社決定、措置実施、再評価、完了証跡	治療を行わず、診療録の保管庫にしない

表記ルール：外部向け資料では「WorkTreatとCASETRAを安全につなぐ連携機能」と説明し、CareLinkを前面ブランドにしません。社内・技術文書では、同期境界と監査証跡の固有名として残します。

クリニックは二入口を守る

入口A：一般診療

かかりつけ医はそのまま。睡眠は専門の内科で。

不眠、SAS、概日リズム、日中の眠気などを患者本人の医療ニーズとして診療します。一般患者に企業契約やWorkTreatを強制しません。

- ・ 患者信頼と診療実績の基盤
- ・ 紹介医との非競合を守る
- ・ 臨床知見を蓄積する

入口B：睡眠・就業両立支援

復職・夜勤・安全配慮を、睡眠から整理する。

仕事の情報、本人同意、睡眠・日中機能、治療状況を整理し、産業医が判断しやすい医学的情報を作ります。

- ・ WorkTreatはこの導線のみ
- ・ 企業へは最小限の就業関連情報
- ・ クリニックは雇用判断をしない

ホームページ上の重要判断：クリニック全体を「復職支援クリニック」に変えてはいけません。一般睡眠外来を主入口として保ち、企業・就業文脈は専用ページへ分離する方が、患者・紹介医・企業の全てに安全です。

標準Caseの完了定義

1. 相談・起票 - 社員 / 人事 / 紹介先からCase ID発行
2. 同意・役割確認 - 共有範囲、主治医、産業医、決定者を確定
3. 医学・就業情報 - 必要時に睡眠評価。会社へ生データは出さない

4. 産業医意見 - 可否だけでなく措置・再評価条件を明示
5. 会社決定 - 事業者が最終決定し、根拠と日付を保存
6. 措置実施 - 短時間、残業、夜勤等の実施確認
7. 再評価・完了 - M3/M6、解除条件、未完了タスクゼロ

役割\局面	診療・治療	医学情報	産業医意見	会社決定	実施・再評価
クリニック / 主治医	担当	本人同意の範囲で提供	担当しない	担当しない	治療側の再診
KIDUKI / 産業医	担当しない	必要情報を評価	担当	助言	措置を再評価
企業	閲覧しない	最小限のみ	受領	最終決定	実施責任
CASETRA	期限・依頼のみ	成果物・同意を管理	意見版を固定	決定証跡	期限・完了・Pack生成

官製様式の「実行エンジン」にする

独自様式を標準として押しつけるのではなく、厚生労働省の勤務情報提供書・両立支援カード・主治医意見書又はこれらに準ずる様式を、WorkTreatで作成・版管理し、CareLinkで公開範囲を限定し、CASETRAで会社の決定と措置実施まで完了させます。様式の利用自体は任意ですが、B001-9を算定する場合は当該様式又は準ずる様式が必要です。

絶対条件：様式のPDF生成を「完了」と呼ばない。会社確認、主治医から産業医等への情報提供、会社決定、措置実施、再評価、証跡固定まで閉じて初めてCase完了とします。

2. 競合は存在する。だから統合の仕方で勝つ

「休復職を扱う」「回復を可視化する」「産業医面談ができる」「健康管理をシステム化する」は、すでに市場にあります。希少性の根拠を睡眠という単語や資格だけに置くと、後発に追いつかれます。

比較対象	すでに強い点	正面衝突しない位置	こちらが証明すべき差
産業医事務所	面談、職場巡視、衛生委員会、休復職判断を一通り提供	一般業務の幅ではなく、難しいCaseの完了と既存産業医の補完	役割分離、期限遵守、措置実施、再評価までの運用品質
Carely等の健康管理SaaS	休復職管理、産業医紹介、面談、意見書、メンタル支援まで企業・産業保健側を広く提供	「医療機関側に立てない」と断定しない。主治医側の診療・算定・診療録・官製様式生成までを自前運用し、企業側と組織間連携する点で土俵を分ける	Carelyが提携で医療側を補完しても残る、役割境界・算定実務・Case完了・再評価の一体運用
eRework等の復職支援	プログラム、回復度の見える化、復職後コンテンツ	回復訓練の置換ではなく、会社の意思決定と就業措置の証跡	既存主治医・既存リワークを活かした接続性
健診機関	企業接点、健診、一般産業保健、保健指導、場合により診療	一般サービスを取りに行かず、高摩擦な休復職Caseの専門出口	紹介後の状況が見えること、健診需要を戻すこと
公的・無料支援	治療と仕事の両立支援に関する相談・訪問・調整	基本相談の有料化ではなく、継続運用と企業内実装を売る	SLA、Case継続、証跡、社内実施、複数Caseへの展開

模倣されやすい

「睡眠にも詳しい産業医」

プロフィールや研修で追従されます。客観指標も単品なら他院が導入できます。

時間がかかる

連携プロトコルと紹介網

紹介品質、返書速度、逆紹介、非競合の実績は、営業資料だけでは再現できません。

最も積むべき

Case完了データと標準

テンプレート、権限、判断版、措置、再評価の運用データがCASETRAに蓄積すると、模倣難度が上がります。

競争優位の階層

Level 1 | 看板

睡眠 × 休職・復職

分かりやすいが、これだけでは弱い。入口のコピー。

Level 2 | 臨床

睡眠覚醒・日中機能・心身状態・就業情報の構造化

睡眠検査は必要時に使う。数値が復職可否を自動決定するとは言わない。

Level 3 | 運用

主治医 → 産業医 → 会社 → 実施 → 再評価の閉ループ

ここから商品としての差が生まれる。

Level 4 | 基盤

CASETRAの権限、テンプレート、DecisionPack、完了データ

複数顧客・複数パートナーに展開可能な参入障壁。

Level 5 | ネットワーク

健診・医療・産業医パートナーの非独占網

紹介を奪わず循環させるほど、接続先としての価値が上がる。

禁止する差別化表現：「国内唯一」「睡眠指標で客観的に復職可否を判定」「一気通貫だから利益相反がない」。同一人物・同一組織内の役割混同はむしろリスクです。差別化は“統合”ではなく、“分離した専門家が標準化されたCaseで連携する構造”に置きます。

Carelyの扱い：公開情報で確認できるのは健康管理SaaS、産業医紹介、休復職・メンタル支援です。自社運営の保険医療機関は本調査では確認できませんでしたが、「将来も医療側を持ってない」という意味ではありません。対抗軸は所有の有無ではなく、主治医側の算定・診療録・様式フローと会社側の実行を、安全に完了できるかです。

3. 商品・収益・流通の設計

一つの顧客に全部を抱き合わせるのではなく、入口を標準化し、必要な層だけ追加します。これにより既存主治医・既存産業医・既存健診機関がいても参加できます。

商品体系

Core

CASETRA

Case起票、Todo、期限、同意、成果物、決定、フォロー、完了。

スケール収益の主役

Pack

休職・復職・就業継続Pack

既存の復職Case、M3/M6、DecisionPackを導入済みテンプレートとして提供。

最初の買う理由

Clinical option

睡眠就業両立支援

医学的に必要な場合のみ診療・評価・情報提供。既存主治医を優先可能。

差別化と症例蓄積

Managed option

KIDUKI運用支援

産業医意見、Case調整、措置案、フォローを提供。既存産業医への補完も可。

初期実証と高難度案件

既存CASETRAとの整合：新しい「復職専用システム」を作らない。現在コード上にある RETURN_TO_WORK_STD / EXT、FU_M3 / FU_M6、DEC-RTW、DecisionPackを、設定済みPackとして前面化します。コードの存在と実運用実績は別なので、最初のKPIは機能数ではなく実Case完了です。

B001-9は「主戦略」ではなく、医療側の収益イネーブルメント

令和8年6月から、療養・就労両立支援指導料は対象疾患の定めが廃止され、初回850点（オンライン740点）、2回目以降500点（オンライン435点、初回算定月から6月を限度）、相談支援加算400点となりました。ただし、就業継続への配慮が必要な患者、会社確認済みの勤務情報、産業医等への情報提供などの要件を満たす場合に限りです。CASETRAの企業売上を保険点数で正当化せず、WorkTreatが医療機関の面倒な算定実務を完了させる補助線として使います。

項目	戦略判断	実装・運用条件
本体指導料	最初の本番Caseは、対象性確認からレセプト請求・返戻確認まで通して営業資産にする	会社確認済み勤務情報、主治医の指導、産業医等への情報提供、様式又は準ずる様式、診療録
相談支援加算400点	業務委託者を算定人員にしない。院内雇用の専任職員を配置・届出できた後のみ算定する	看護師・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれか、両立支援コーディネーター養成研修修了、施設基準届出、療養上の指導への同席と相談支援
採用判断	400点だけを根拠に先行採用しない。相談支援・調整・継続支援を含む院内業務全体で稼働を設計する	月間対象Case数、同席可能枠、完全人件費、他業務価値を3か月ローリングで判定

修正された投資原則：Proof段階は、本体指導料の算定完走を先に証明します。相談支援加算は、院内の専任職員を実際に確保し施設基準を届け出るまでは売上計画に入れません。採用前は加算ゼロで採算が成り立つ設計にします。

実装済みと、まだ証明していないことを分ける

領域	ローカルで確認できた資産	本番で未証明のこと
WorkTreat	両立支援カード、会社確認、B001-9ゲート、PDF、診療録格納、6か月フォローに対応する実装	実患者・実会社での本番完走、請求・審査、返書運用、例外処理
CareLink	公開範囲、同意版、文書メタ、配慮要約を扱うイベント / APIと権限制約	撤回・再送・重複・障害時復旧を含む本番監査、全画面の情報最小化
CASETRA	復職Case種、M3/M6、DecisionPack、WorkTreat同期面	異なる提供者・紹介元でも同じ完了率と工数で回るか、課金軸が受容されるか

収益階段

層	誰が払う	収益の意味	戦略上の制約
クリニック診療	患者 / 保険 / 自費	臨床基盤、患者価値、紹介信頼、医学的知見	企業送客のための囲い込みにしない
KIDUKI Managed	企業	難しいCaseの解決、初期収益、運用標準の実証	最終的に売上構成比を下げ、人月商売化を防ぐ
CASETRA Readiness Core	企業 / 産業医事務所 / 健診機関	規程・役割・同意・証跡保管・制度改定追従に対する反復課金	狭いCoreの月1.98万円仮説を検証。現行Starter月4万円とのプラン境界を混同しない
CASE実行課金	企業又は提供者	発生が間欠な休復職案件に、起票から完了までの価値で課金	Coreのみ、Caseのみ、Core + CaseをProofでA/Bし、粗利と受容性で決定
Options	既存契約者	追加Case、権限、SSO/API、Evidence Vault等	利用証拠のない機能を先に増やさない
Partner / OEM	パートナー	人を増やさず流通を拡大	ブランド・責任分界・一次対応を標準化

顧客のメリットを明確にする

企業・人事

迷いと抜け漏れを減らす

- 誰に何を依頼中か見える
- 会社決定と実施の証跡が残る
- 再評価期限を失わない
- 生の診療情報を抱え込まない

社員・患者

説明を何度も繰り返さない

- 同意範囲が明確
- 治療と就業判断が混同されない
- 睡眠・日中機能も適切に考慮
- 既存主治医や希望医療機関を選べる

紹介元・パートナー

難しい案件の出口を持てる

- 紹介後の進捗と返書が得られる
- 一般診療・健診顧客を奪われない
- 自社サービスの提案範囲が広がる
- 紹介料ではなく相互価値で組める

採血・生活習慣病を「紹介の通貨」にする

睡眠診療上必要な採血は外部検査・連携先を利用できる一方、長期の高血圧・糖尿病・脂質異常症管理を囲い込まない設計にします。主治医がいる患者は原則その主治医へ、主治医不在の未治療者は本人の選択で連携内科へつなぎ、睡眠領域だけを返してもらいます。

関係者	明確なメリット	約束する運用
患者	睡眠と全身状態の見落としを減らしつつ、通いやすい主治医を持てる。診療の重複と説明の往復を減らせる。	紹介理由・検査結果・睡眠診療の継続範囲を明記し、医療機関の選択を本人に残す。
紹介先内科	継続管理を必要とする新規患者が来る。睡眠問題はクリニックへ戻せるため、自院の専門外負担を増やさない。	処方の重複を避け、速やかな診療情報提供と逆紹介後の役割表を付ける。
睡眠クリニック	専門性を薄めず、必要な全身評価を確保し、紹介元との信頼を積める。	生活習慣病管理料の最大化ではなく、睡眠診療に必要な範囲だけ保持する。

実務原則：採血の外注は単なるコスト削減ではなく、紹介先との接点づくりに使います。ただし検査会社への業務委託と、患者を診療する連携医療機関は法的・契約的に別物なので、責任主体・結果説明・異常値対応を曖昧にしません。

健診機関を流通の中核にする

健診機関は「一般的な産業保健」をすでに提供できる前提で扱います。実際に芝健診センターは健診、巡回健診、産業医・保健師、外来・紹介まで持ち、東京通信病院は人間ドックのSAS簡易検査と院内診療を持っています。したがって「出口がない」と決めつけず、通常機能では処理コストが高い休職・復職・就業継続Case、広域・時間外、複数組織間の証跡管理に限定して提案します。

候補	最初の提案	こちらのGive	求めるもの
芝健診センター	既存の産業医・保健師・外来では工数が重い休復職Caseの補完。既存人的接点を活かし、最初から高価値テーマで入る	健診・再検査需要の紹介、専門外来・企業向け知見、紹介後の標準返書	企業営業 / アフターケア窓口への紹介導線、1〜3 Caseの共同検証
半蔵門病院	近隣の一般内科・健診・入院機能と、当院の睡眠就業両立支援を補完関係にする	採血、生活習慣病、画像、入院等の逆紹介。睡眠領域は当院で継続	地域連携窓口、検査・逆紹介・緊急時の役割表
東京通信病院	SAS簡易検査と院内診療を前提に、広域・夜間土日・就業継続支援・復職Caseの補完を提案	高度検査・入院・専門診療への逆紹介、本人希望時のオンライン継続支援	ドック部門と呼吸器内科の既存導線を尊重した、対象限定パイロット

挨拶の順序：「CASETRAを買ってください」から入らない。①相手がすでに持つ機能を理解していると示す、②なお手離れが悪いCaseを具体化、③こちらが引き取る範囲、④必ず戻す患者・健診需要、⑤返書と情報境界、⑥1〜3件の共同検証、の順です。実績ができてからCASETRAを共同運用基盤として提案します。

Regulatory Calendar——外部の強制力に発売時期を合わせる

時期	制度変化	商品への落とし込み
2026年4月1日	治療と就業の両立を促進するための措置が事業主の努力義務	Readiness Coreに相談体制、役割、規程、本人申出、記録、再評価の標準を収録
2026年6月	B001-9の対象疾患拡大、点数・期間・相談支援評価の見直し	WorkTreatを算定実務エンジンとして実Caseで証明。400点は院内専任職員を配置後のみ
2026-2027年	小規模事業場向けストレスチェック導入準備	まず休復職Caseで提供者チャネルを作り、規程・記録・面接後のCase管理へ横展開
2028年4月1日	50人未満事業場にもストレスチェック実施義務	健診機関・社労士・産業医組織向けPartner/OEMを波の前に販売可能にする

情報ガバナンス

情報	クリニック	産業医	会社	CASETRAでの扱い
診療録・検査生データ	保持	原則不要 / 必要時は同意	閲覧不可	診療システム側。安易に複製しない
本人の希望・就業情報	診療に必要な範囲	評価に使用	本人・会社入力分を保持	同意と出所を明記
医学的情報提供書	作成	受領・評価	必要最小限の結論のみ	版・送付先・同意を固定
産業医意見	必要範囲のみ	作成	受領	確定版と再評価条件を固定
会社の決定・措置実施	必要時に共有	確認	決定・実施責任	実施日・責任者・確認証跡

利益相反ゲート：同一社員について、同じ医師がクリニック主治医と企業側産業医を兼ねない。KIDUKIが当該企業の産業医を担う場合は、治療側または産業医側を独立した別医師・別医療機関へ割り当てます。システムでも役割競合を警告・禁止する設計が必要です。

Webサイトの尖らせ方

KIDUKI

Hero休職・復職・就業継続を、判断で終わらせず、実行と再評価まで。

- Packを第一画面
- 睡眠は差別化の根拠として第二階層
- 一般産業医業務は「対応可能」と下層に置く

CASETRA

Hero復職Caseを、依頼から措置解除まで一つに。

- 第一ユースケースを復職に固定
- 全機能は隠さず「導入後の拡張」として表示
- 復職PackのデモをCTAにする

Clinic

Dedicated route復職・夜勤・安全配慮を、睡眠と日中機能から整理します。

- 一般睡眠外来を主入口のまま維持
- 両立支援は専用ページと紹介用URL
- 「産業医面談ではない」を明記

GTM : 狭く入り、広く使ってもらう

順番	市場	入口	CASETRA拡張
1	既存ネットワーク・既存顧客	まず生Case在庫を棚卸し。3件以上あれば最初の1件を算定・再評価まで完走	健康相談・休職判定・M3/M6を追加
2	芝・半蔵門・逋信	専門出口 + 返書 + 逆紹介	共同Caseボード / 紹介進捗
3	社労士・弁護士・他産業医事務所	難Caseを補完し、既存顧問を奪わない	Partner版、テンプレート配布
4	全国の健診機関・産業医組織	検証済みPack	OEM / Partner販売
5	企業内の横展開	復職で信頼を獲得	高ストレス、長時間、健診事後、健康相談

90日実行計画

DAY 0-14

在庫と境界を凍結

- ・ 顧問先の生Case棚卸し
- ・ 官製様式マッピング
- ・ RACI・同意・COIゲート
- ・ CareLink公開項目の固定

DAY 15-30

最初の本番Case

- ・ 会社確認→診療→情報提供
- ・ B001-9請求・返戻追跡
- ・ 会社決定・措置実施
- ・ 加算は院内専任職員なしならゼロ

DAY 31-60

紹介ループを作る

- ・ 芝・半蔵門・逋信へ挨拶
- ・ 1〜3 Caseの限定試行
- ・ 逆紹介・返書を実行
- ・ 手作業分数を計測

DAY 61-90

課金と再現性

- Core / Case / 併用をA/B
- 紹介元リピートを確認
- 公開用算定ガイド
- Partner要件決定

スケールの段階目標

以下は売上予測ではなく、次の投資を許可するための検証基準です。実績に合わせて更新します。

段階	検証規模	確認すること	次に解禁する投資
Proof	生Case在庫を起点に最低3実Case、3紹介元候補	算定、完了条件、情報境界、工数、返書、再評価が機能するか	Pack LP、限定販売、テンプレート修正
Repeatability	10〜20社、累計30〜50 Case	担当者が変わっても同じ手順で回るか、粗利が成立するか	Partner版、オンボーディング自動化
Expansion	100社、複数Case種	復職を入口に健康相談・高ストレス等へ広がるか	SSO/API、追加Pack、営業投資
Platform	1,000社規模、複数Partner/OEM	自社医師が介在しなくても標準と証跡が維持されるか	全国流通・業界標準化

人月化防止KPI：1 Case当たりの自社調整時間、1社当たり月間サポート時間、Partner一次解決率を必ず追います。初期にManaged比率が高いのは許容しても、スケール段階では診療・Managed売上への依存を下げることを経営条件にします。

経営ダッシュボード

Case完了率

完了条件を満たし閉じた割合。単なる面談完了ではない。

Cycle time

起票→医学情報→産業医意見→会社決定→実施の各日数。

再評価遵守率

M3/M6等を期限内に実施し、解除・継続を決めた割合。

Expand率

復職Pack導入後、別Case種を追加した企業の割合。

領域	最初に測るもの	まだ広告に使わないもの
運用	期限遵守、未完Todo、文書版管理、実施確認	症状改善、再休職低下など未検証アウトカム
営業	適格相談、デモ→試行、試行→契約、紹介元別ARR	市場唯一、導入社数No.1
プロダクト	Pack起動率、完了率、手作業時間、別Case追加	コード上にあるだけの機能を「実績」と呼ぶこと
医療	一般 / 両立支援の予約を分離、返書日数、同意完備	睡眠指標だけで就業可否を予測できるとの主張

追加する先行KPI：紹介元の90日以内リピート率、COI発動後の再経路化完了率、B001-9の適格→算定率、返戻・査定率、CareLink送信→受領確認率、1 Case当たり自社調整分数。相談支援加算は院内専任職員配置後にのみ「対象件数・算定件数・職員稼働率」を追加します。

投資ゲートと撤退条件

進める条件

- ・ 5〜10件で同じ工程と成果物が再利用できる
- ・ 企業がCase完了と証跡に対価を払う
- ・ パートナーが非独占でも紹介する
- ・ 復職から別Caseへ自然に拡張する

止めて直す条件

- ・ 医師・担当者の個別調整が毎回必要
- ・ 会社が睡眠評価のみを買い、CASETRAを使わない
- ・ 役割競合や同意不備が解消できない
- ・ 紹介元に返せる価値がなく送客が続かない

この戦略で「やらないこと」

- ・ 生活習慣病管理料を成長の主戦場にしない。必要な診療は行っても、主治医がいる患者を奪わず、採血・一般管理は連携先へ返す。
- ・ 健診機関と一般産業医業務・健診後フォローの幅で競争しない。
- ・ 全機能を同じ強さでホームページに並べない。
- ・ 臨床の生データ、企業判断、産業医意見を一つの閲覧権限に混ぜない。
- ・ 顧客事例がない段階で、アウトカム効果や模倣不能性を断言しない。

加えてやらない：相談支援加算400点を見込んで業務委託者を配置すること、院内専任職員の届出前に加算収益を予算化すること、CareLinkを患者向け第四ブランドとして販売すること。

最終到達像

Managed companyではなく、産業保健のCase standardになる。初期はKIDUKIとクリニックが案件を完了させて標準を磨く。次に健診機関・産業医事務所が同じPackを使う。最終的には提供者が自社であっても他社であっても、Caseの進行・権限・成果物・決定・再評価がCASETRA上で標準化される状態を取ります。

4. 根拠・確認範囲・前提

制度・競合・公開サイトは2026年8月5日時点の公開情報、実装状態はローカル資産を基に整理しました。公開事例やコードの存在を、顧客成果の証拠とは扱っていません。

制度・公的ガイド

- 1 Official [厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」](#) — 本人の意向、主治医・産業医等の意見、事業者による措置・計画という責任分担。
- 2 Official [厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」](#) — 五つのステップ、主治医判断と職務遂行能力の違い、睡眠覚醒リズム・日中の眠気等の評価例。
- 3 Official [厚生労働省 令和8年版 両立支援カード等](#) — 主治医と事業場の情報連携書式。
- 4 Official [厚生労働省「療養・就労両立支援指導料のご案内（令和8年度改定版）」](#) — 初回850点 / オンライン740点、2回目以降500点 / 435点、相談支援加算400点、専任職種・研修要件、様式利用の位置づけ。
- 5 Official [地方厚生局 様式8の3](#) — 相談支援加算の施設基準届出における専任職員、職種、研修修了の添付事項。
- 6 Official [厚生労働省「治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務に」](#) — 2026年4月1日施行。
- 7 Official [厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」](#) — 50人未満事業場への義務化は2028年4月1日施行。
- 8 Public option [労働者健康安全機構 治療と仕事の両立支援ナビ](#) — 無料支援が存在するため、有料事業は実装・継続・証拠で価値を出す必要がある。

競合・代替手段

- 1 [Carely メンタルヘルス支援、産業医紹介](#) — 休復職、面談、意見書、産業医紹介等の企業・産業保健側サービス。自社運営の保険医療機関は本調査では確認できず。
- 2 [アドバンテッジ eRework](#) — 復職支援プログラムと回復可視化の公開説明。
- 3 [Be Health](#) — 産業保健・健康管理システムの代替カテゴリ。
- 4 [日本産業医事務所](#) — 一般的な産業医サービスの競争環境。

自社公開サイト・連携候補

- 1 [スリープリカバリークリニック番町](#)、[睡眠と仕事の相談](#)、[WorkTreat](#) — 一般診療と両立支援の二入口、情報共有方針。
- 2 [KIDUKIコンサルティング産業医事務所](#) — 現行の睡眠・安全・生産性を軸とした公開訴求。
- 3 [芝健診センター](#)、[半蔵門病院 人間ドック・定期健診](#)、[東京通信病院 人間ドックセンター](#) — 連携候補がすでに持つ健診・外来・アフターケア機能。東京通信病院はSAS簡易検査と院内SAS診療も公開。
- 4 [全国労働衛生団体連合会](#) — 中長期の健診機関チャネル候補。現時点の提携関係を意味しない。

ローカルで確認した実装・戦略資産

Clinic : clinic-wordpress-site/docs/site-overview.md 、公開ページソース、二入口とWorkTreatの適用範囲。

KIDUKI : kdk-wordpress/kiduki/docs/core-thesis.md 、 integrated-story.md 、 rebrand-strategy.md 。

CASETRA : casetra_active 内の復職Case種別、M3/M6、DecisionPack、公開料金。実コードの存在は確認済みだが、本番の実Case完遂実績は別途検証が必要。

CareLink : casetra_active/kiduki-consult-api/docs/ARCHITECTURE_CARELINK_SHARED_CORE.md 、WorkTreat側の careLinkEvent.ts 、 casetraBalanceSupportEvent.ts 。公開済み最小情報、同意版、公開範囲、文書メタ、ACKの境界を確認。

WorkTreat : treatwork-os-mvp/docs/WORKTREAT_MIN_OUTLINE_RYORITSU_CARD_20260710.md と実装記録。両立支援カード、会社確認、B001-9ゲート、PDF、フォロー機能を確認。実請求の審査結果は未確認。

Clinic strategy : Open-Clinic/Strategy/HP戦略_睡眠障害内科_完全版v2_20260724.md 等の役割分離・逆紹介方針。

未確認事項

- 顧客インタビュー、商談録、問い合わせログ、GA4/Search Console、CRMの需要データは本書では精査していない。
- 芝・半蔵門・東京逋信との提携意思・担当窓口・契約条件は未確認であり、すべて候補仮説。
- CASETRAの復職フローが本番で何件完遂されたか、手作業工数、障害率、継続率は未確認。
- 相談支援加算の算定人員は業務委託不可・院内専任職員を前提に本書を修正した。雇用形態、兼任範囲、届出時期を含む個別施設基準は、採用・算定前に管轄厚生局へ書面確認する。
- 診療報酬の個別算定、医療広告、個人情報、利益相反、紹介契約は、実装前に専門家と個別確認が必要。

証拠の優先順位：公的制度・顧客の実行データ・パートナーの実際の紹介行動を上位とし、自社サイトの表現や競合の自己申告は補助情報として扱います。